

# Epidemiologische surveillance van het rotavirus

2025

**Auteur C. Dambre<sup>1</sup>**

**Revisie L. Cuypers<sup>2</sup> • J. Matthijnsens<sup>2</sup> • P. Carrillo<sup>3</sup> • H. Theeten<sup>4</sup> • N. Hammami<sup>4</sup>**

*<sup>1</sup>Epidemiologie van infectieziekten, Sciensano; <sup>2</sup>Nationaal Referentiecentrum voor rotavirus, UZ/KU Leuven ; <sup>3</sup>Fédération Wallonie-Bruxelles; <sup>4</sup>Departement Zorg;*

# Hoofdpunten

## **Sterke toename van gerapporteerde gevallen in 2025**

Volgens de gegevens van de peillaboratoria werden 5092 gevallen gerapporteerd in 2025, een stijging van 75% ten opzichte van 2024 en het hoogste aantal sinds de introductie van vaccinatie.

## **Stijging voornamelijk bij oudere leeftijdsgroepen**

Hoewel de stijging zich voordeed bij de meeste leeftijdsgroepen, is deze meer uitgesproken naarmate leeftijd toeneemt. Voornamelijk bij personen 80 jaar en ouder werd een bijna vertienvoudiging van het aantal gevallen gezien.

## **Toename grotendeels te verklaren door veranderingen in diagnostiek**

De verschuiving naar PCR-gebaseerde multiplex testen heeft geleid tot hogere detectie en meer diagnoses. Een reële toename in viruscirculatie kan echter niet worden uitgesloten.

## **Genotype G2P[4] opnieuw dominant in 2025**

Na enkele jaren een volledige dominantie van genotype G3P[8] te observeren in België, nam het aandeel van dit genotype terug af in 2025, terwijl genotype G2P[4] opnieuw in frequentie toenam.

## **Vaccinatie aanbevolen voor alle zuigelingen**

Rotavirus blijft een belangrijke oorzaak van gastro-enteritis. Het virus is zeer besmettelijk en kan leiden tot ziekenhuisopname, vooral bij jonge kinderen. Vaccinatie wordt dan ook aanbevolen door de Hoge Gezondheidsraad voor alle zuigelingen.

# Inhoudstafel

|                                                      |           |
|------------------------------------------------------|-----------|
| <b>1. Beschrijving van de surveillance.....</b>      | <b>4</b>  |
| 1.1. Gegevensbronnen .....                           | 4         |
| 1.1.1. Gevalsdefinitie .....                         | 4         |
| 1.1.2. Representativiteit van de gegevens .....      | 4         |
| <b>2. Resultaten .....</b>                           | <b>5</b>  |
| 2.1. Resultaten peillaboratoria.....                 | 5         |
| 2.1.1. Trends per jaar .....                         | 5         |
| 2.1.2. Trends per leeftijdsgroep .....               | 6         |
| 2.1.3. Trends per gewest.....                        | 7         |
| 2.1.4. Trends gebruik van diagnostische testen ..... | 7         |
| 2.2. Seizoenscurve .....                             | 9         |
| 2.3. Verdeling genotypes .....                       | 10        |
| 2.4. Ziekenhuisopnames en mortaliteit.....           | 11        |
| 2.4.1. Ziekenhuisopnames .....                       | 11        |
| 2.4.2. Mortaliteit .....                             | 11        |
| <b>3. Belang voor de volksgezondheid .....</b>       | <b>12</b> |
| <b>Meer informatie .....</b>                         | <b>13</b> |
| <b>Referenties .....</b>                             | <b>13</b> |

# 1. Beschrijving van de surveillance

De surveillance van het rotavirus in België is gebaseerd op verschillende gegevensbronnen, die in dit rapport geïntegreerd worden besproken.

## 1.1. Gegevensbronnen

- **Netwerk van peillaboratoria (Epilabo):** een vrijwillig netwerk van laboratoria dat diagnostische gegevens rapporteert aan Sciensano. Rotavirus testgegevens worden sinds 1999 geregistreerd, met een tijdelijke onderbreking van de surveillance tussen 2002 en 2004.
- **Nationaal Referentiecentrum (NRC) voor rotavirus (UZ/KU Leuven):** verantwoordelijk voor de moleculaire surveillance van circulerende rotavirustypes via genotypering. Het NRC analyseert een subset van stalen die op vrijwillige basis worden opgestuurd door laboratoria.
- **Minimale Ziekenhuisgegevens (MZG):** alle niet-psychiatrische ziekenhuizen in België zijn verplicht bij te dragen aan de geanonimiseerde registratie van administratieve, medische en verpleegkundige gegevens over ziekenhuisopnames. Sinds 2016 worden diagnoses gecodeerd volgens de *International Classification of Diseases*, 10e revisie (ICD-10). De gegevens zijn beschikbaar met een vertraging van twee jaar.
- **Mortaliteitsgegevens:** verzameld via overlijdensakten, geregistreerd door de Vlaamse en Franse Gemeenschap en gecentraliseerd door Statbel. Sinds 1998 worden doodsoorzaken gecodeerd volgens de *International Classification of Diseases*, 10e revisie (ICD-10). De gegevens zijn beschikbaar met een vertraging van drie jaar.

### 1.1.1. Gevalsdefinitie

Een bevestigde rotavirusinfectie wordt door de Wereldgezondheidsorganisatie (WHO) gedefinieerd als: “isolatie van rotavirus of detectie van rotavirus-antigeen of nucleïnezuur in de stoelgang”. Deze gevalsdefinitie wordt gevolgd door de peillaboratoria en het NRC. Voor de MZG baseren we ons op ziekenhuisverblijven met als hoofddiagnose de code ICD10-A080 (rotavirus enteritis), die ook wordt gebruikt bij het coderen van de mortaliteitsgegevens.

### 1.1.2. Representativiteit van de gegevens

Geen van deze gegevensbronnen is exhaustief, waardoor het niet mogelijk is het absolute aantal rotavirusinfecties in België in te schatten, maar zijn wel geschikt om trends te volgen.

Het Epilabo-surveillancesysteem is gebaseerd op vrijwillige deelname van laboratoria. De dekking werd in voorgaande jaren geschat op basis van RIZIV-terugbetalingsgegevens voor rotavirus testen bij kinderen <2 jaar (verhouding tests uitgevoerd door deelnemende laboratoria ten opzichte van het nationale totaal) en bedroeg 43% in 2023. Door het toegenomen gebruik van PCR-multiplex-panels voor gastro-intestinale pathogenen, die momenteel niet terugbetaald worden, is deze benadering niet langer toepasbaar. De representativiteit van het netwerk wordt daarom dit jaar enkel geëvalueerd op basis van het aantal deelnemende laboratoria en hun geografische spreiding.

In totaal rapporteerden 47 laboratoria minstens één geval in 2025, waarvan 34 in Vlaanderen, 4 in Brussel en 9 in Wallonië. Deze verdeling is stabiel over de laatste 5 jaren, met een gekende en blijvende ondervertegenwoordiging van Brussel en vooral van Wallonië.

De minimale ziekenhuisgegevens vertonen deze geografische variatie niet, aangezien alle Belgische ziekenhuizen verplicht zijn deel te nemen. Er moet echter rekening gehouden worden met enkele beperkingen: deze gegevens werden aanvankelijk niet voor epidemiologische doeleinden verzameld en diagnose en codificatie van ziekten kunnen variëren tussen ziekenhuizen.

## 2. Resultaten

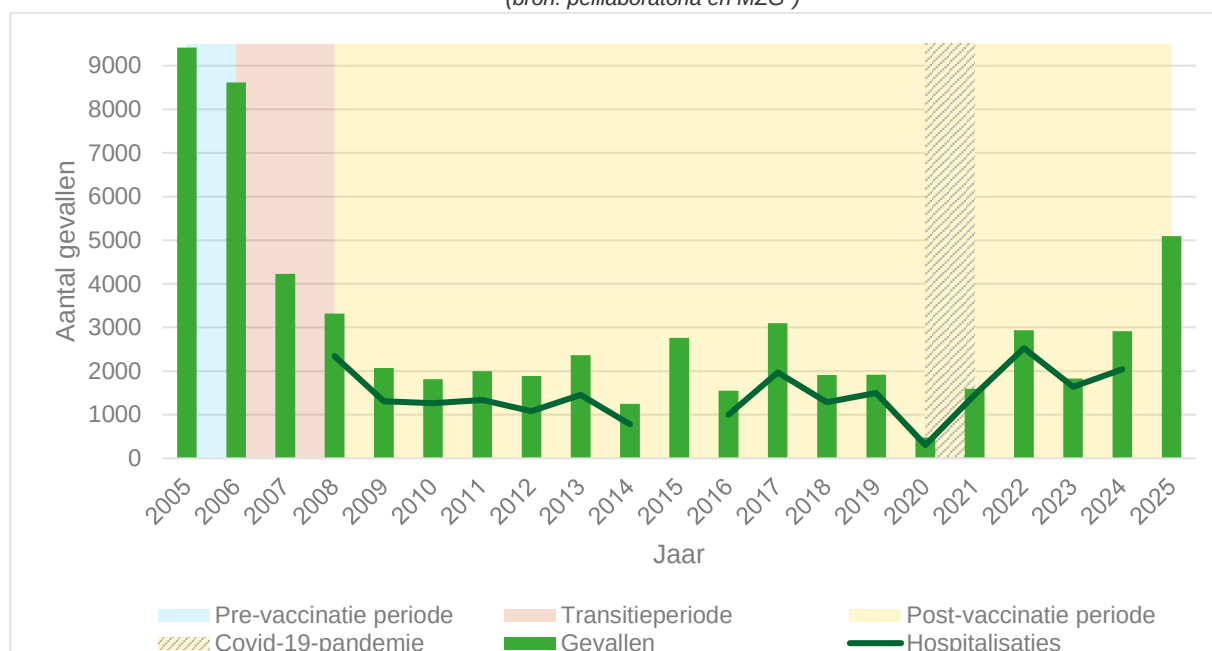
### 2.1. Resultaten peillaboratoria

#### 2.1.1. Trends per jaar

Het jaarlijkse aantal gerapporteerde rotavirusgevallen en hospitalisaties wordt weergegeven in Figuur 1. Er wordt een onderscheid gemaakt tussen de pre-vaccinatieperiode (tot juni 2006), de transitieperiode waarin vaccinatie werd ingevoerd (juli 2006-juni 2008), en de post-vaccinatieperiode (vanaf juli 2008). Sinds de aanbeveling van de Hoge Gezondheidsraad in 2006 om zuigelingen te vaccineren, met gedeeltelijke terugbetaling van de vaccins, is het aantal bevestigde infecties aanzienlijk gedaald ten opzichte van de pre-vaccinatieperiode.

In 2025 werd een sterke toename in gevallen gerapporteerd binnen de peillaboratoria, met 5092 rotavirusinfecties. Dit is een stijging van 75% ten opzichte van 2024 (n=2912) en betreft het hoogst aantal gerapporteerde gevallen sinds de introductie van vaccinatie. Het aantal ziekenhuisopnames voor 2025 is nog niet beschikbaar op het moment van schrijven van dit rapport.

**Figuur 1: Aantal bevestigde gevallen van rotavirus en aantal gerapporteerde hospitalisaties per jaar, 2005-2025, België**  
(bron: peillaboratoria en MZG\*)



\*De minimale ziekenhuisgegevens zijn niet beschikbaar voor 2015 ten gevolge van de codewijziging van ICD-9 naar ICD-10.

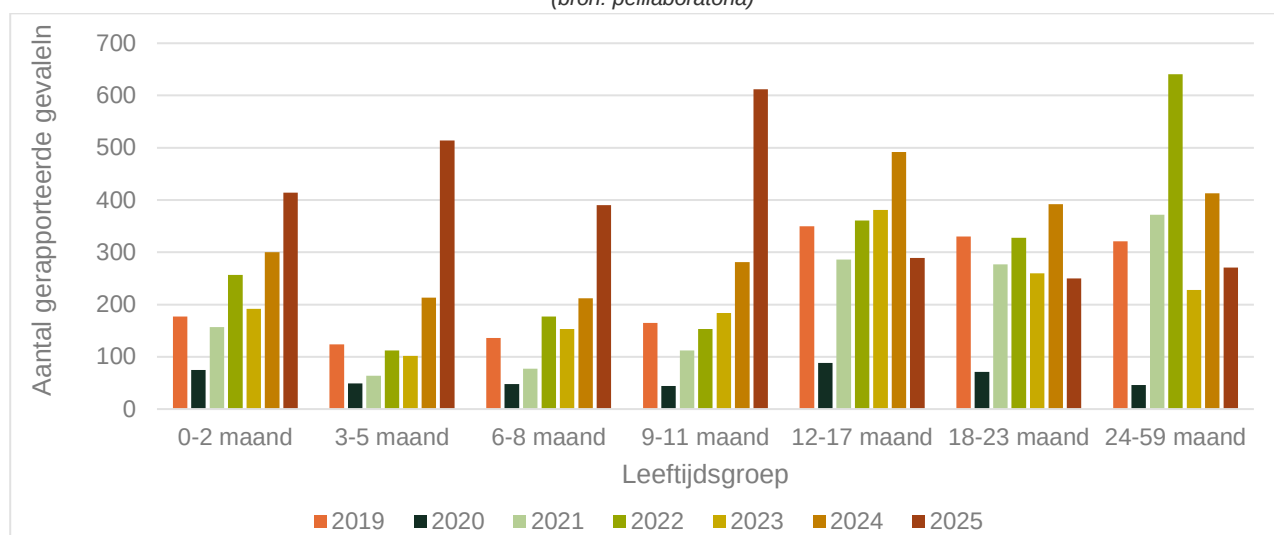
## 2.1.2. Trends per leeftijdsgroep

Bij kinderen onder de vijf jaar werd de toename in 2025 waargenomen in alle leeftijdsgroepen van 0-11 maand. In totaal werd bij deze kinderen jonger dan 1 jaar (n=1930) bijna een verdubbeling in aantal gevallen ten opzichte van 2024 waargenomen. Bij kinderen 12-59 maanden daalde het aantal gevallen met 37.5% (810 in 2025 ten opzichte van 1297 in 2024) (Figuur 2).

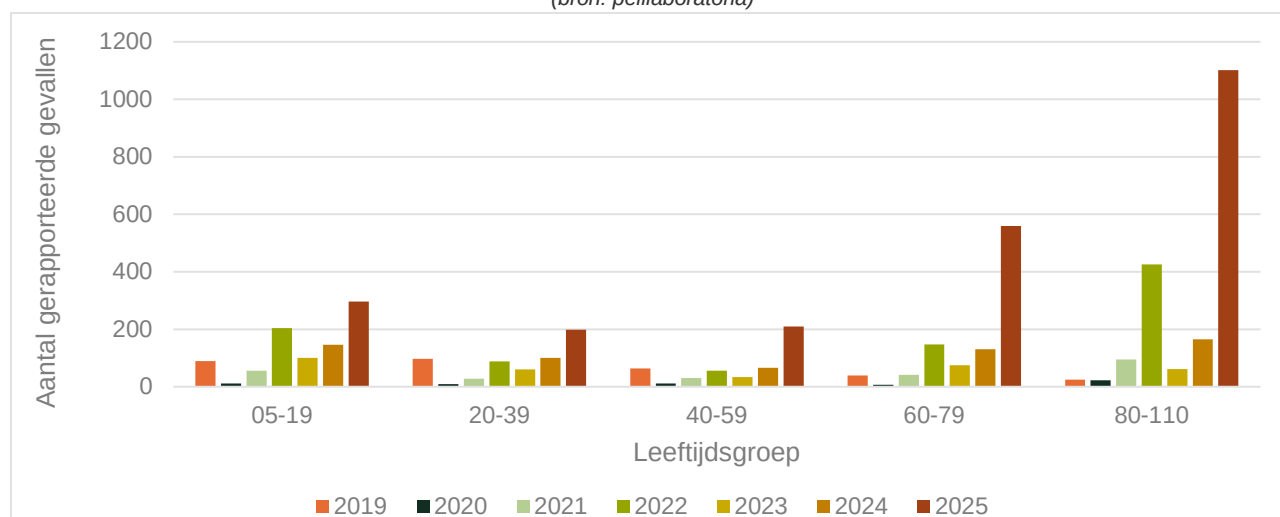
Voor patiënten ouder dan 5 jaar werd een relatieve toename in aantal gevallen geobserveerd, die toenam met toenemende leeftijd (Figuur 3). Bij 5-19-jarigen (n=297) en volwassenen 20-39 jaar (n=199) werd een verdubbeling in aantal gevallen ten opzichte van 2024 waargenomen. In de leeftijdsgroep 40-59 jaar en 60-79 jaar waren de stijgingen nog uitgesprokener, met respectievelijk 210 gevallen (+218%) en 559 gevallen (+326%).

De meest uitgesproken toename werd echter gezien bij personen van 80 jaar en ouder. In deze groep schommelde het aantal gevallen in de afgelopen jaren tussen 25 en 170, met uitzondering van het jaar 2022 (n=426). In 2025 steeg dit aantal tot maar liefst 1102 gevallen (Figuur 3).

**Figuur 2: Aantal gerapporteerde rotavirusinfecties bij kinderen onder 5 jaar, per leeftijdsgroep, per jaar, 2019-2025**  
(bron: peillaboratoria)



**Figuur 3: Aantal gerapporteerde rotavirusinfecties 5-110 jaar, per leeftijdsgroep, per jaar, 2019-2025**  
(bron: peillaboratoria)

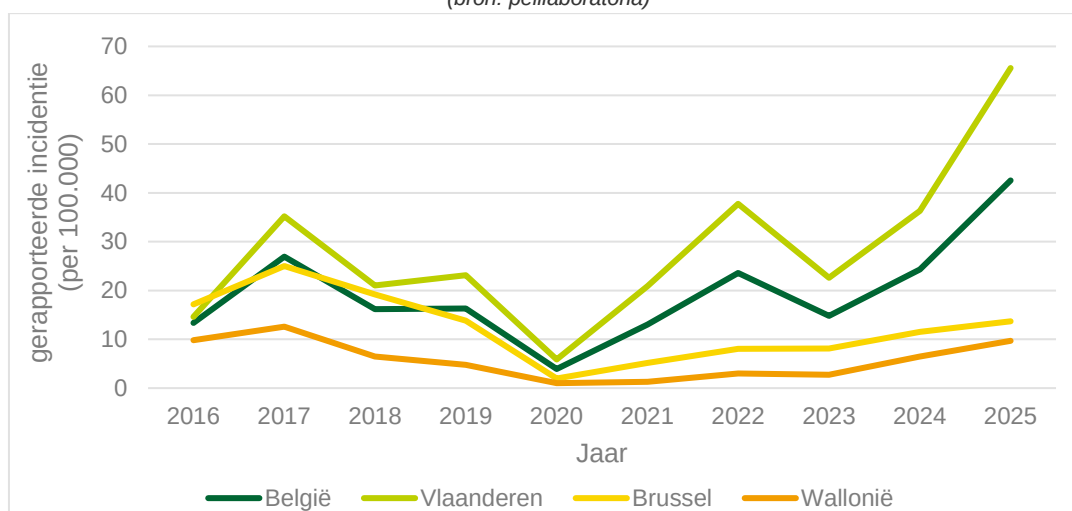


### 2.1.3. Trends per gewest

Het aantal bevestigde gevallen in 2025 bedroeg 42.5 per 100.000 inwoners in heel België. In alle regio's werd een toename vastgesteld ten opzichte van 2024 (Figuur 4), echter deze was opvallend meer uitgesproken in Vlaanderen dan in Wallonië en Brussels. Vlaanderen kende de hoogste gerapporteerde incidentie: 65.6 per 100.000 inwoners (n=4501). De sterke toename in Vlaanderen wordt waargenomen in alle Vlaamse provincies, maar voornamelijk in de provincies West-Vlaanderen en Oost-Vlaanderen werden uitzonderlijk hoge aantallen gerapporteerd, 139 per 100 000 inwoners en 66 per 100 000 respectievelijk (41-46 per 100 000 in andere Vlaamse provincies).

In het Brussels Hoofdstedelijk Gewest steeg de gerapporteerde incidentie tot 13.7 per 100.000 inwoners (n=172). In Wallonië tot slot bedroeg deze 9.7 per 100.000 inwoners (n=358).

**Figuur 4: Gerapporteerde incidentie van rotavirusinfecties (aantal bevestigde gevallen per 100 000 populatie), per gewest, 2016-2025**  
(bron: peillaboratoria)



*Door gekende onderrapportering binnen het netwerk van peillaboratoria in Brussel en Wallonië wordt de werkelijke ziektelast in deze regio's onderschat. Vergelijkingen tussen regio's op basis van deze gegevens zijn daardoor moeilijk te interpreteren. Het is daarom beter om trends binnen elke regio afzonderlijk te analyseren, in plaats van regio's onderling te vergelijken.*

### 2.1.4. Trends gebruik van diagnostische testen

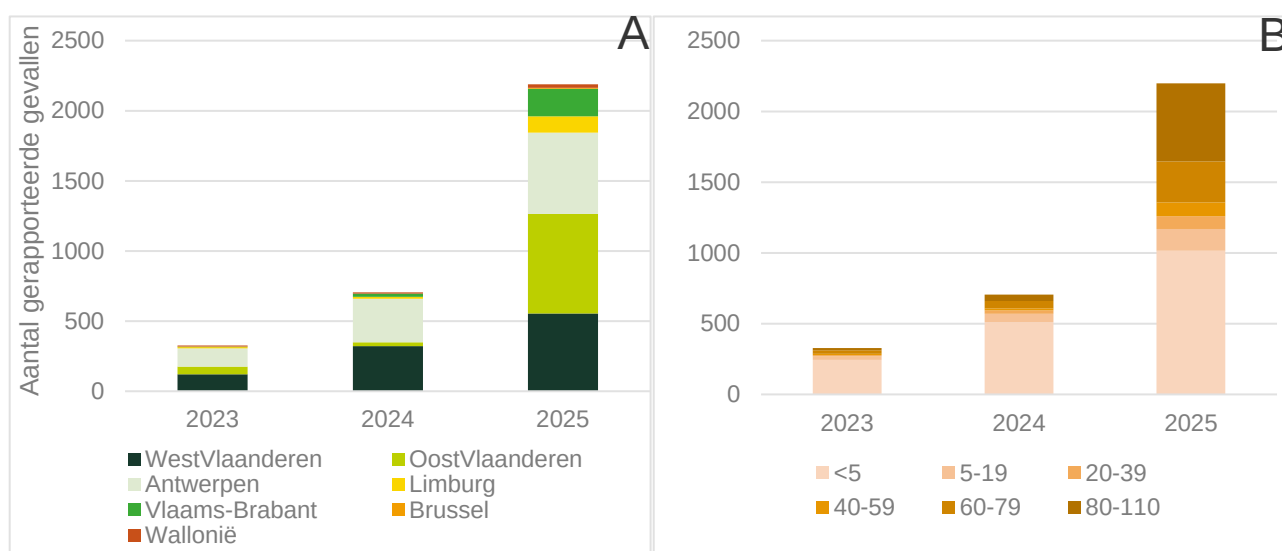
Een opvallende trend in 2025 is de sterke toename van het aantal rotavirus gevallen dat via PCR werd gedetecteerd (Tabel 1). Deze stijging contrasteert met eerdere jaren, waarin antigeentesten de dominante diagnostische methode waren. De toename hangt waarschijnlijk samen met de introductie en het toenemend gebruik van gastro-intestinale multiplex PCR-panelen in ziekenhuiscontext.

**Tabel 1: Testmethode gebruikt voor de diagnose van rotavirusinfecties, 2019-2025, België**  
(Bron: peillaboratoria)

| Jaar | Antigeen | Cultuur | Microscopie | PCR  | PCR/Total | Serologie | Andere | Onbekend | Total |
|------|----------|---------|-------------|------|-----------|-----------|--------|----------|-------|
| 2019 | 1480     | 4       | 19          | 68   | 4 %       | 1         | 20     | 327      | 1919  |
| 2020 | 344      | 3       | 0           | 30   | 6 %       | 1         | 13     | 93       | 484   |
| 2021 | 1167     | 3       | 0           | 131  | 8 %       | 0         | 52     | 242      | 1595  |
| 2022 | 2268     | 9       | 1           | 87   | 3 %       | 1         | 101    | 472      | 2939  |
| 2023 | 1149     | 15      | 5           | 326  | 18 %      | 2         | 46     | 284      | 1827  |
| 2024 | 1269     | 26      | 0           | 706  | 24 %      | 0         | 1      | 910      | 2912  |
| 2025 | 1529     | 32      | 3           | 2198 | 43 %      | 4         | 41     | 1285     | 5092  |

Analyse van de stijging in PCR testen toont dat deze zich voornamelijk voordeed in Vlaanderen (Figuur 5A). In alle Vlaamse provincies werd een toename vastgesteld, met de meest uitgesproken stijging in Oost-Vlaanderen. In de Waalse provincies en in Brussel werden daarentegen slechts weinig rotavirus gevallen via PCR gediagnosticeerd (25 in Wallonië en 7 in Brussel in 2025, versus 2157 in Vlaanderen in 2025). Ook per leeftijdsgroep is een duidelijke toename van PCR-diagnoses zichtbaar in alle leeftijdsgroepen. De procentuele stijging is het grootst bij de oudste leeftijdsgroep, waar het aantal PCR-testen in 2025 meer dan tien keer hoger lag dan in 2024 (Figuur 5B).

**Figuur 5: aantal PCR-gediagnosticeerde rotavirusinfecties, per provincie (A) en per leeftijdsgroep (B), 2023-2025**  
(bron: peillaboratoria)



Deze resultaten suggereren dat de toename in PCR-tests sterk geassocieerd is met de stijging in het aantal gerapporteerde gevallen in 2025, met name bij ouderen en in Vlaanderen.

Echter, wanneer we alle PCRs en onbekenden excluderen wordt in België een toename van gevallen van 25% waargenomen ten opzichte van het voorgaande jaar, volledig gedreven door een toename in Vlaanderen, terwijl de aantallen in Brussel en Wallonië stabiel bleven of afnamen. Dit wijst erop dat ook een reële toename in viruscirculatie mogelijk heeft bijgedragen aan de stijging in 2025.

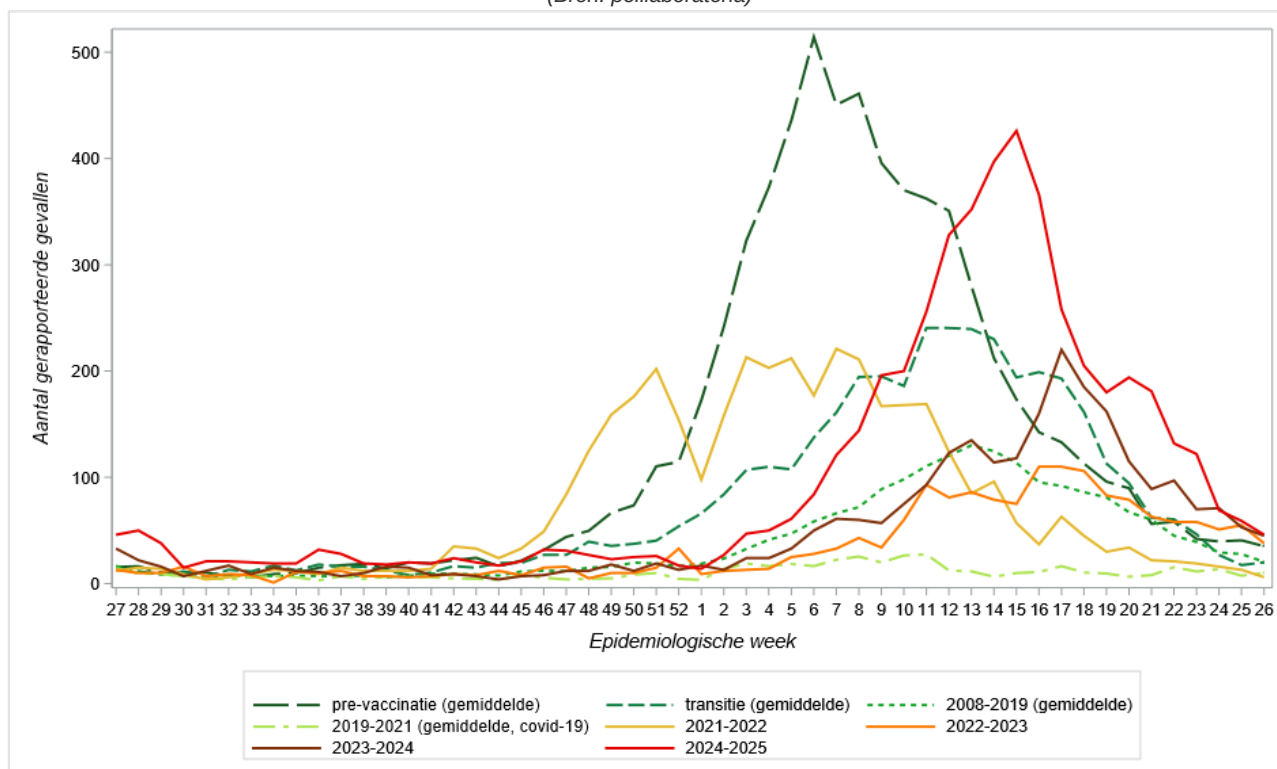
## 2.2. Seizoenscurve

Rotavirusinfecties vertonen een duidelijk seizoensgebonden patroon, met jaarlijks een epidemische piek in de wintermaanden (Figuur 6). In 2025 begon het rotavirusseizoen<sup>1</sup> in februari (week 7) en duurde het 18 weken, met een piek in april toen 467 gevallen werden geregistreerd in week 15. Dit is de hoogste piek sinds de pre-vaccinatieperiode. De timing van dit seizoen was vergelijkbaar met 2023, met een piek in april maar met een beduidend lager aantal gevallen (220 in week 17).

De introductie van rotavirusvaccinatie heeft de seizoenscurves aanzienlijk beïnvloed. Niet alleen nam de intensiteit van de piek af, ook verschoof de timing. In de pre-vaccinatieperiode werd de piek doorgaans rond week 6 waargenomen, terwijl deze post-vaccinatie verschoof naar week 13. Bovendien waren de seizoenen na vaccinatie doorgaans korter.

Deze trend werd doorbroken tijdens de COVID-19-pandemie, toen uitzonderlijk weinig gevallen werden gerapporteerd en er nauwelijks sprake was van een klassiek rotavirusseizoen. Het daaropvolgende seizoen (2021-2022) verliep atypisch, met een vroege start en een eerste piek reeds in week 51 van 2021, gevolgd door een brede verspreiding over de wintermaanden. In de daaropvolgende seizoenen verschoof de piek opnieuw naar latere tijdstippen (ongeveer week 16) en eindigde het seizoen later dan gebruikelijk in de post-vaccinatieperiode. Ook het seizoen 2024-2025 volgt dit post-COVID patroon.

**Figuur 6: Gemiddeld aantal gerapporteerde gevallen van rotavirus per week tijdens de pre-vaccinatieperiode (1999-2006), de transitieperiode (2006-2008), de post-vaccinatie periode (2008-2019), de COVID-19 periode (2019-2021) en de laatste vier seizoenen in België**  
(Bron: peillaboratoria)



<sup>1</sup> De start van het rotavirusseizoen wordt door de WHO gedefinieerd als de week waarin het aantal gevallen voor het eerst het gemiddeld aantal gevallen per week voor het hele jaar overstijgt. (1)

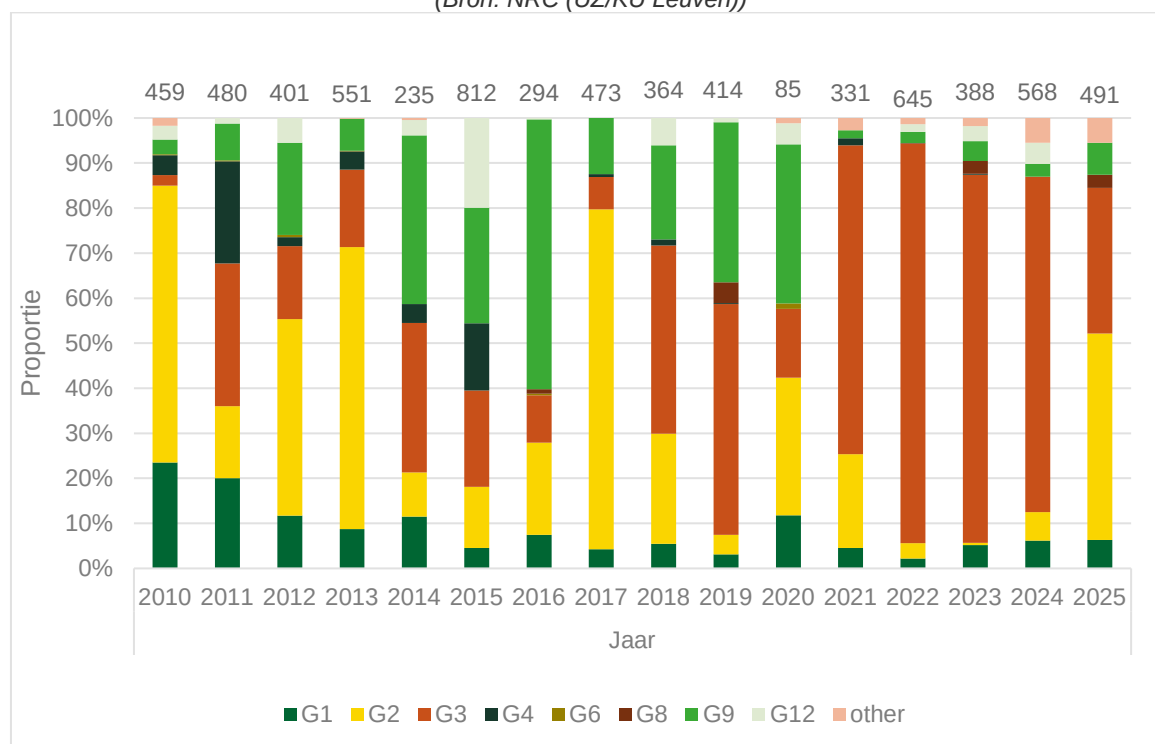
## 2.3. Verdeling genotypes

Genotypes G1P[8], G2P[4], G3P[8], G4P[8] en G9P[8] overheersen in Europa over de jaren heen. De verdeling van de circulerende genotypes varieert echter van jaar tot jaar en elk jaar wordt een co-circulatie van meerdere stammen waargenomen (Figuur 7). Het NRC staat in voor de genotypering van rotavirussen in België.

In 2025 werd een duidelijke verschuiving in de verdeling van genotypes vastgesteld en neemt de proportie van G3P[8], dat de afgelopen jaren het dominante genotype was, terug af. Dit type was verantwoordelijke voor 31% van de getypeerde gevallen, terwijl G2P[4] en G2P[8] toenamen in frequentie en samen 46% van de gevallen vertegenwoordigden.

Sinds het atypische rotavirusseizoen 2021-2022 domineerde genotype G3P[8] sterk. Analyses door het NRC tonen dat het voornamelijk gaat om de 'equineline' G3P[8] variant, die in 2014 voor het eerst ontdekt werd in België en sindsdien langzamerhand de humane G3P[8] variant heeft vervangen (2). De oorzaak van deze opmerkelijke dominantie is niet volledig gekend, maar wordt vermoedelijk beïnvloed door natuurlijke variatie en een bottleneck in circulerende genotypes door de COVID-19-lockdowns. Een verminderde effectiviteit van Rotarix® tegen dit genotype werd gesuggereerd, maar de evidentie is beperkt en niet eenduidig. Ook lijkt de herverdeling van genotypes in 2025, zonder wijzigingen in vaccinatiebeleid, eerder te wijzen op natuurlijke variatie.

Figuur 7: verdeling van de circulerende rotavirus genotypes per jaar, 2010-2025  
(Bron: NRC (UZ/KU Leuven))



## 2.4. Ziekenhuisopnames en mortaliteit

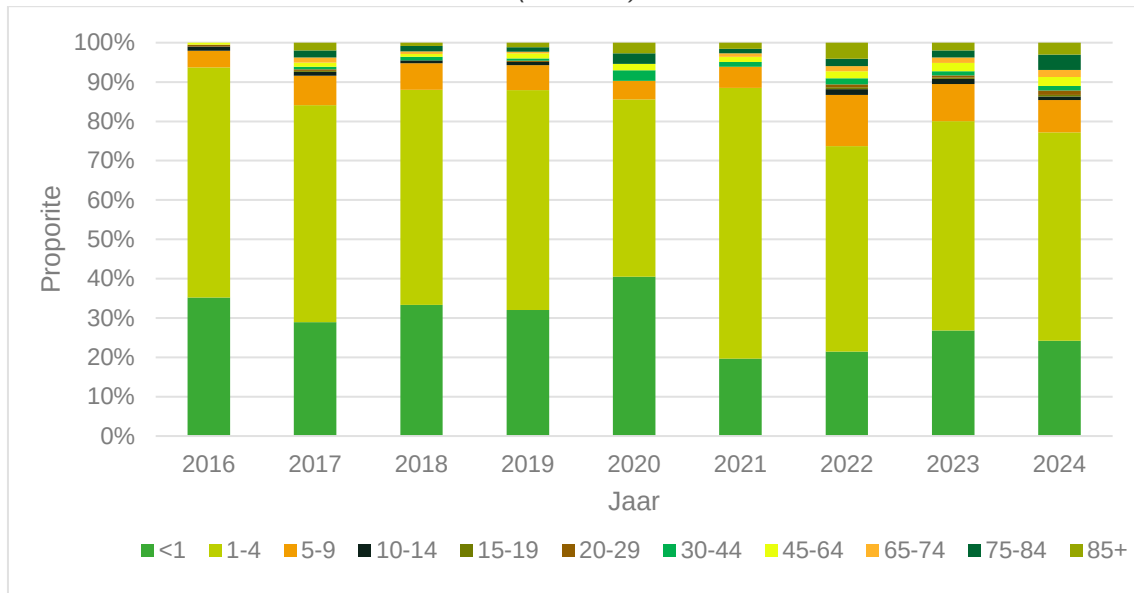
### 2.4.1. Ziekenhuisopnames

De grote meerderheid van de ziekenhuisopnames omwille van rotavirus gastro-enteritis over de jaren betreft kinderen jonger dan 5 jaar (Figuur 8). In 2024 waren er 2039 hospitalisaties ten gevolge van rotavirus gastro-enteritis (Figuur 1), waarvan 77% bij kinderen onder 5 jaar (n=1574). Dit komt overeen met een incidentie van 3 opnames per 1000 kinderen onder 5 jaar in België.

Ook de leeftijdsgroep 5-9 jaar wordt getroffen, maar in veel mindere mate. Sinds 2022 werd een opvallende toename gezien in het aandeel hospitalisaties bij deze groep, vermoedelijk gerelateerd aan verminderde rotavirus circulatie als gevolg van preventieve maatregelen tijdens de COVID-19-pandemie, waardoor het immuunsysteem van deze kinderen minder 'natuurlijk' boosters ontving. In 2024 lijkt dit aandeel terug te normaliseren en maakt deze groep nog 8% (n=168) van alle ziekenhuisopnames uit.

Bij personen van 75 jaar en ouder werden in 2024 meer hospitalisaties gerapporteerd dan in 2023. Het valt af te wachten of de sterke toename in positieve (PCR) testen bij ouderen in 2025 zich ook zal vertalen in een toename van hospitalisaties ten gevolge van rotavirus gastro-enteritis (data nog niet beschikbaar).

Figuur 8: Aantal ziekenhuisopnames ten gevolge van rotavirus gastro-enteritis, per leeftijdsgroep, 2016-2024  
(Bron: MZG)



### 2.4.2. Mortaliteit

Sterfgevallen die worden toegeschreven aan rotavirus gastro-enteritis zijn uiterst zeldzaam. In de periode 2019-2022 werden slechts 3 sterfgevallen gemeld volgens de overlijdensaktes verzameld door Statbel. Deze deden zich allen voor bij personen ouder dan 90 jaar. Sinds 2008, de post-vaccinatieperiode werden geen sterfgevallen meer gerapporteerd bij kinderen onder 5 jaar.

### 3. Belang voor de volksgezondheid

Rotavirus veroorzaakt acute gastro-enteritis, gekenmerkt door braken en waterige diarree. Wereldwijd blijft diarree een belangrijke doodsoorzaak bij kinderen onder 5 jaar, met naar schatting 120.000 sterfgevallen door het rotavirus in 2021, vooral in lage-inkomenslanden (3). In hoge-inkomenslanden is sterfte door diarree zeldzaam, maar rotavirus blijft een frequente oorzaak van ziekenhuisopnames bij jonge kinderen, voornamelijk door uitdroging.

In België zijn twee rotavirusvaccins beschikbaar, die sinds november 2006 deels worden terugbetaald: Rotarix® (monovalent, bevat humaan rotavirus genotype G1P[8]) toegediend op 8 en 12 weken, en RotaTeq® (pentavalent, bevat humane genotypes G1, G2, G3, G4 en P[8]) toegediend op 8, 12 en 16 weken. Beide zijn afgezwakte levende vaccins die oraal worden toegediend en bieden goede bescherming tegen ernstige vormen van rotavirus gastro-enteritis (VE: 84-91%) (4). De introductie van vaccinatie heeft de epidemiologie van rotavirus in België sterk veranderd. In de periode na introductie werd een daling van 79% in rotavirusinfecties bij kinderen <2 jaar en een reductie van 87% in hospitalisaties gerapporteerd ten opzichte van de pre-vaccinatieperiode (5). Daarnaast hebben vaccins ook het rotavirus seizoen en de verdeling van genotypes beïnvloed (6).

Ondanks deze duidelijke voordelen van vaccinatie blijft de vaccinatiegraad in België suboptimaal. Naar schatting werd 79.5% van de kinderen geboren in 2022 volledig gevaccineerd tegen rotavirus. Bovendien bestaan er grote geografische en socio-economische ongelijkheden (7). Een verdere verhoging van de vaccinatiegraad, bijvoorbeeld via opname in de gratis vaccinatieprogramma's, zou deze ongelijkheden kunnen verkleinen en de resterende ziektelast verder verminderen.

In 2025 werd het hoogste aantal gerapporteerde gevallen sinds de introductie van vaccinatie waargenomen. De stijging situeert zich vooral bij personen ≥80 jaar en voornamelijk in Vlaanderen. Deze toename moet in de eerste plaats worden geïnterpreteerd in het licht van belangrijke veranderingen in diagnostische praktijken. De introductie en het toenemend gebruik van PCR-multiplexpanels heeft vermoedelijk geleid tot een bredere testindicatie en hogere detectie, vooral bij oudere leeftijdsgroepen, waar rotavirus testen in het verleden niet vaak werden uitgevoerd omdat antigeentesten niet worden terugbetaald door het RIZIV bij patiënten ouder dan 2 jaar. Hierdoor verschuift de surveillance van een voornamelijk pediatrie focus naar een bredere populatie, wat een groot deel van de leeftijdsspecifieke stijging kan verklaren. Daarnaast zijn de PCR testen gevoeliger dan antigeentesten, waardoor ook zwak positieve resultaten en co-infecties vaker worden gedetecteerd. Bijgevolg zijn de cijfers in 2025 niet rechtstreeks vergelijkbaar met voorgaande jaren.

Hoewel deze diagnostische verschuiving waarschijnlijk een belangrijk deel van de toename verklaart, kan een reële stijging in viruscirculatie niet worden uitgesloten. Ook internationaal worden gelijkaardige toenames gerapporteerd. Zo rapporteerde het Verenigd Koninkrijk een stijging van 50% in het seizoen 2024-2025 ten opzichte van het voorgaande seizoen (8), en werd in Finland eveneens een algemene toename vastgesteld, met een uitgesproken stijging bij oudere leeftijdsgroepen, zonder aanwijzingen voor gewijzigde testpraktijken.

Voor toekomstig surveillance is het essentieel om systematisch informatie te verzamelen over testindicaties en gebruikte diagnostische methoden om trends beter te kunnen standaardiseren. Daarnaast blijven verdere epidemiologische en genotypische surveillance belangrijk. Hierdoor kunnen nieuwe genotypes of antigene drift tijdig worden gedetecteerd en kan de impact van vaccinatieprogramma's voor jonge kinderen blijvend worden geëvalueerd.

## Meer informatie

- Informatie over vaccinatie tegen rotavirus: [Hoge Gezondheidsraad](#)
- Algemene informatie over rotavirus: [ECDC](#)
- Epidemiologische rapporten voorgaande jaren: [Sciensano](#)
- NRC rapporten en publicaties: [NRC rotavirus](#)
- Europees netwerk voor rotavirus surveillance: [EuroRotaNet](#)
- Wereldwijde vaccinatiegraad rotavirus: [WHO](#)

## Referenties

1. Rotavirus: Vaccine Preventable Diseases Surveillance Standards [Internet]. [cited 2026 Apr 10]. Available from: <https://www.who.int/>
2. Karataş M, Bloemen M, Cuypers L, Wollants E, Van Ranst M, Matthijnssens J. 14 years of rotavirus A surveillance: unusual dominance of equine-like G3P[8] genotype with DS-1-like genotype constellation after the pandemic, Belgium, 2009 to 2023. *Eurosurveillance*. 2025 Mar 27;30(12):2400442.
3. GBD 2021 Diarrhoeal Diseases Collaborators. Global, regional, and national age-sex-specific burden of diarrhoeal diseases, their risk factors, and aetiologies, 1990-2021, for 204 countries and territories: a systematic analysis for the Global Burden of Disease Study 2021. *Lancet Infect Dis*. 2025 May;25(5):519-536. doi: 10.1016/S1473-3099(24)00691-1. Epub 2024 Dec 18. PMID: 39708822; PMCID: PMC12018300.
4. Hoge Gezondheidsraad [Internet]. [cited 2026 Apr 10]. Rotavirus. Available from: <https://www.hgr-css.be/nl/advies/8812/rotavirus>
5. Sabbe M, Berger N, Blommaert A, Ogunjimi B, Grammens T, Callens M, et al. Sustained low rotavirus activity and hospitalisation rates in the post-vaccination era in Belgium, 2007 to 2014. *Eurosurveillance*. 2016 Jul 7;21(27):30273.
6. Zeller M, Rahman M, Heylen E, De Coster S, De Vos S, Arijs I, et al. Rotavirus incidence and genotype distribution before and after national rotavirus vaccine introduction in Belgium. *Vaccine*. 2010 Nov 3;28(47):7507–13.
7. Dambre C, Rousseau R, Hansford K, Cornelissen L. Rotavirus vaccination in Belgium : trends and inequalities. [Internet]. [cited 2026 Apr 10]. Available from : <https://www.sciensano.be/nl/biblio/rotavirusvaccinatie-belgie-trends-en-ongelijkheden>
8. UK Health Security Agency. National norovirus and rotavirus report, week 28 report: data to week 26 (data up to 29 June 2025). [Internet]. [cited 2026 Apr 10]. Available from: <https://www.gov.uk/government/statistics/national-norovirus-and-rotavirus-surveillance-reports-2024-to-2025-season/national-norovirus-and-rotavirus-report-week-28-report-data-to-week-26-data-up-to-29-june-2025#contents>

*Dit project wordt financieel ondersteund door :*



Volksgezondheid  
Veiligheid van de Voedselketen  
Leefmilieu



Wallonie  
families santé handicap  
AVIQ



## CONTACT

Epidemiologische surveillance vaccineerbare infectieziekten: [vpd@sciensano.be](mailto:vpd@sciensano.be)

## OVER SCIENSANO

Sciensano is een openbaar en onafhankelijk wetenschappelijk instituut, dat zich inzet voor de gezondheid van mens en dier en hun omgeving.

We doen wetenschappelijk onderzoek en surveillance, en ondersteunen de overheid en verschillende agentschappen en organisaties met expertise, adviezen en diensten op vlak van gezondheid.

Sciensano hecht veel belang aan het One Health-principe, dat benadrukt dat de gezondheid van mens, dier en hun omgeving onderling verbonden zijn. Daarom is ons onderzoek interdisciplinair en integreert het verschillende invalshoeken.

Met meer dan duizend medewerkers en 120 jaar aan wetenschappelijke expertise, is Sciensano een gerenommeerd wetenschapsinstituut, dat deel uitmaakt van verschillende internationale wetenschappelijke netwerken.

### MEER INFO

Sciensano.be – [info@sciensano.be](mailto:info@sciensano.be)

Juliette Wytsmanstraat 14 • Brussel • België • T + 32 2 642 51 11